EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 72508
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-10-16 12:44:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: REBECA VERONICA BELMAR BELMAR			RUN	: 8.451.931-6
F.Nac	: 01-11-1955	Edad	: 67 AÑOS, 11 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-10-12	Fecha Egreso	: 2023-10-16 12:44:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Insuficiencia Respiratoria Aguda
-Neumonía Multifocal
Nefropatía diabética
Anemia moderada
HTA
DLP
DMT2
ACV Trombolizado

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente fémina con antecedentes mórbidos HTA, DLP, DM2 IR , ACV Trombolizado sin secuela. Niega Alergia Inicia enfermedad actual hace 4 dias cuando presenta escalofrios, tos seca, disnea, la cua se excerba el dia e ayer en horas de la tarde por lo que acude APS desaturando se apoya con venturi a 10 litros se deriav para urgencia con Obs de TEP al ingreso Saturando 94% Con Venturi En 10 Lts , Hipertensa , Taquicardica , Taquipneica Sub Febril. Al Ex. Fisico Gls 15 Pts, Yugulares Planas, Torax Simetrico Ventilando Con Uso De Musculatura Accesoria Al Ingreso, Eess Sin Lesiones, Abdi , Eeii Sin Lesiones Ni Edema, Se Toman Exs De Sangre + Gsa (35%) , gasometría arterial pH : 7,38 pCO2 : 27,5 pO2 : 122,2 se realiza Angio tac de Torax Examen Sin Signos De Tromboembolismo Pulmonar. Derrame Pericárdico Leve. Derrame Pleural. Neumonía De Predominio En Lóbulo Superior Derecho. AL Ingreso sala paciente con mayor compromiso respiratorio, us de la musculatura accesoria se indica gasometría control pH : 7,47 pCO2 : 28,6 pO2 : 62,3 se indica cnaf evaluación por UTI.
Durante estancia hospitalaria paciente con uso de CNAF con disminución de requerimientos de oxígeno de manera progresiva además de parámetros inflamatorios en descenso. Actualmente en mejores condiciones generales, con 24h sin requerimiento de oxígeno, aún bajo terapia ATB acorde. Se indica alta médica a domicilio para continuidad de terapia ATB + Kinésica.

PLAN DE MANEJO:

Cumplir terapia ATB
Manejo terapia Kinésica

Control poli medicina <30 días

INDICACIONES AL ALTA

1. Ceftriaxona 2 Gr Ev
2. Azitromicina 500 Mg Dia Vo
3. Prednisona 20mg vo c8h
4. Carvedilol 6,25mg Cada 12hrs Vo
5. Amlodipino 10mg Dia Vo
6. Atrovastatina 40mg Dia Vo
7. Aspirina 100 Mg Dia Vovo
8. Losartan 50 Mg 1 Cada 12hrs
9. Omeprazol 20mg Vo
10. Captopril 25 mg SL >180/110mmHg
11. Kine Respiratoria y Motora interdiario
12. Control SOS

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO